

认知健康SaaS平台 商业需求文档（BRD）

版本：V2.0

日期：2026年5月

产品定位：面向B端的认知健康数字疗法SaaS平台

1. 执行摘要

1.1 产品定位

认知健康SaaS平台是一款**AI驱动的数字疗法产品**，面向B端医疗机构、养老机构、社区卫生服务中心，同时服务C端老年用户及其家属。通过标准化的认知筛查量表、AI智能分析系统、全流程健康管理闭环，构建“筛查-评估-干预-随访”的完整认知健康服务生态。

1.2 核心价值

- 医疗机构端**：提高筛查效率，降低医生工作负荷，实现患者全周期管理
- 养老/社区端**：标准化筛查工具，批量完成认知健康建档，降低运营成本
- 用户端**：早期发现认知风险，获得专业干预指导，延缓疾病进展

1.3 预期目标

- 上线6个月**：覆盖50+医疗机构，服务用户5万人
- 上线12个月**：覆盖200+机构，服务用户20万人，实现月度盈亏平衡
- 上线24个月**：成为国内认知筛查领域标杆产品，启动数字疗法医疗器械认证

2. 市场背景与机会

2.1 行业数据

指标	数据	来源

中国认知障碍患者人数	超过5,000万	中国老龄科学研究中心
轻度认知障碍患病率	15%-20%（65岁以上）	《中国阿尔茨海默病报告2025》
早期就诊率	不足30%	中华医学会神经病学分会
认知障碍市场规模	预计2030年达5,000亿元	艾瑞咨询
数字疗法市场增速	年复合增长率45%	Frost & Sullivan

中国60岁以上人口超2.9亿，轻度认知障碍（MCI）患病率约15-20%，就诊率不足30%。数字疗法市场规模2025年约50亿元，年复合增长率超40%。

2.2 市场痛点

B端痛点：

- 医疗机构缺乏标准化筛查工具，人工评估效率低下
- 养老/社区缺乏专业认知健康管理能力
- 患者随访管理困难，数据碎片化严重

C端痛点：

- 老年人难以区分正常老化与认知下降
- 传统纸质问卷操作复杂，老人难以独立完成
- 发现风险后缺乏明确就医路径和干预方案

2.3 竞争分析

竞品	模式	优势	劣势	我们的差异化
脑动极光	C端训练游戏	游戏化设计粘性高，训练数据积累多	B端SaaS能力弱，缺乏批量管理	B+C双轮驱动，SaaS模式覆盖机构需求
六六脑	C端+部分B端	专业认知训练内容	界面复杂，老人门槛高，B端数据管理有限	适老化设计，语音交互降低门槛
博而美	医院院内筛查	MMSE/MoCA量表专业，临床认可度高	仅筛查无干预，社区/居家场景弱	筛查+训练干预一体化，轻量化H5部署

3. 用户分析

3.1 核心用户画像

B端用户（付费方）： - **医疗机构神经内科/记忆门诊：** 主任/副主任医师，40-55岁，需要提升筛查效率和患者管理能力 - **养老机构运营总监：** 35-45岁，需要标准化健康管理工具，提升服务品质 - **社区卫生服务中心：** 公卫科负责人，30-45岁，需要完成公共卫生筛查任务

C端用户（使用者）： - **老年人：** 55-80岁，有一定健康意识，可能存在记忆力下降困扰 - **子女家属：** 30-50岁，关注父母健康，是主要决策人和付费意愿最强的群体

3.2 用户痛点深度分析

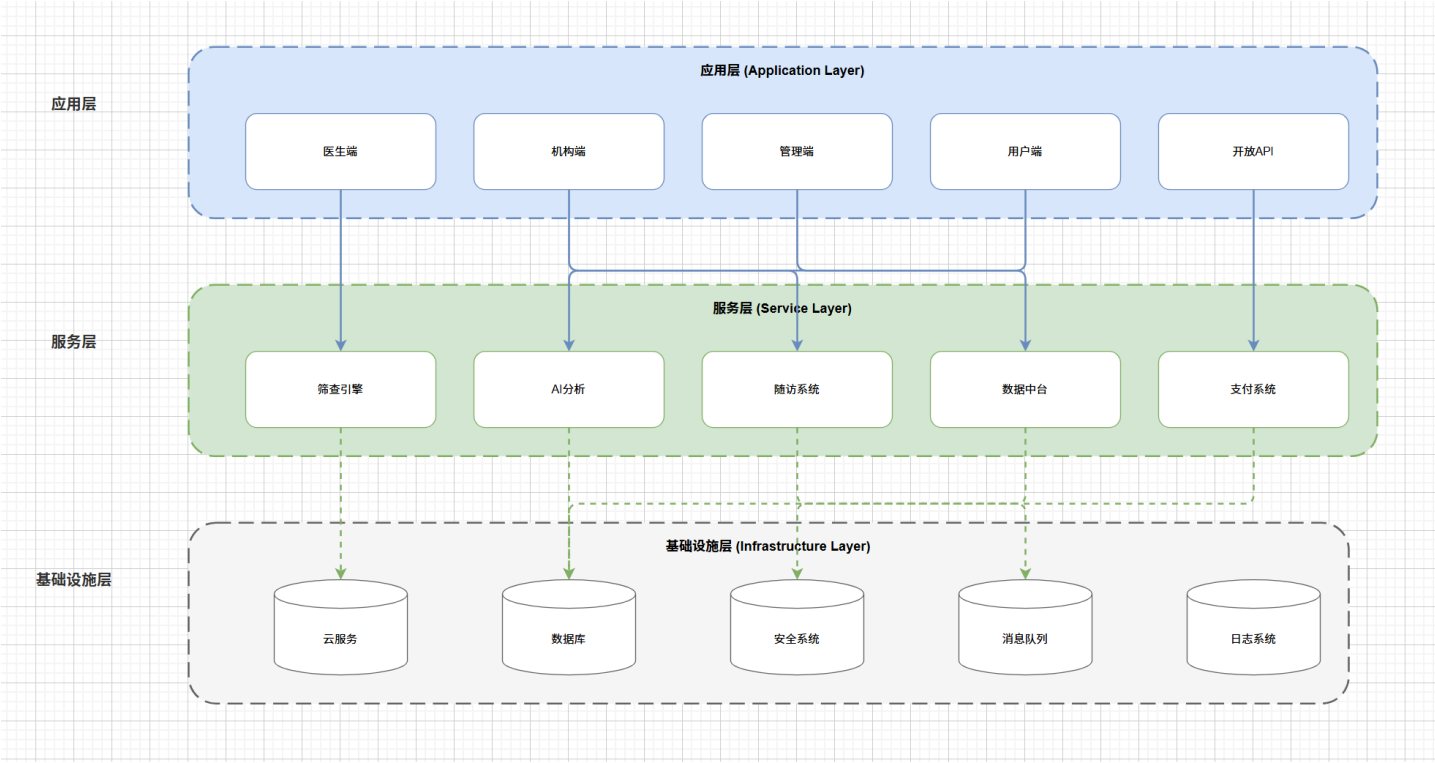
用户角色	核心痛点	需求层次
B端机构	无标准化筛查工具，数据碎片化，随访靠人工	标准化工具、数据管理、降本增效
C端老人	操作困难，看不清文字，不会用手机	语音交互、适老化设计、简单易用
C端家属	发现风险后就医迷茫，缺乏干预方案	就医指引、全程管理、专业可靠

4. 产品定位与核心功能

4.1 产品定位

面向B端的「AI+SaaS+数字疗法」三位一体认知健康管理平台

4.2 系统架构



5. 商业模式与盈利预测

5.1 收入模式

收入来源	模式说明	目标客户
SaaS订阅费	基础版1.5万/年（含1000次筛查），专业版3万/年（含5000次筛查+AI分析+客户成功）	医疗机构、养老机构
按患者收费	30元/月/患者，机构按需购买筛查额度	社区卫生服务中心
在线问诊佣金	10-20元/单，与问诊平台分成	C端中高风险用户
认知训练课程	99元/月，用户自愿订阅或机构打包销售	C端用户及家属

5.2 定价策略

产品版本	定价	包含服务
基础版	1.5万元/年	最多5个账号，1000次筛查/年，数据看板+风险分层

专业版	3万元/年	最多20个账号，5000次筛查/年，AI分析报告+客户成功
C端增值服务	99元/月	认知训练课程+在线问诊+专属健康管家

5.3 三年营收预测

指标	第1年	第2年	第3年
付费机构数	5	50	200
SaaS收入（万元）	7.5	150	600
C端增值收入（万元）	2	30	120
总营收（万元）	约10	约180	约720

6. 市场推广与获客策略

6.1 B端获客渠道

渠道	策略	预期效果
直销团队	重点攻坚三甲医院神经内科和标杆养老机构	建立行业背书，形成示范效应
渠道代理	与医疗信息化厂商、养老设备厂商合作分销	快速拓展客户触达面
医疗信息化展会	参加神经病学年会、养老产业博览会	精准触达目标客户，建立品牌认知
政府合作	参与公共卫生筛查项目采购，争取政策补贴	获得批量机构入口，降低获客成本

6.2 C端获客策略

- **B端带C端**：通过机构筛查自然获取C端用户
- **家属裂变**：子女完成筛查后自动分享，形成社交传播
- **内容营销**：科普短视频、公众号文章，建立专业形象

6.3 合作模式

- **医院合作**：免费部署+按次分成模式，降低准入门槛

- 养老机构：SaaS年费+增值服务分成
- 政府项目：参与公共卫生服务采购，争取政策补贴

7. 关键指标与里程碑

7.1 核心指标体系

业务指标： - 付费机构数：目标第1年5家，第2年50家，第3年200家 - 活跃机构占比：≥80% - 续约率：≥90% - 人均筛查成本：持续下降

产品指标： - 筛查完成率：≥85% - 报告满意度：≥4.5/5分 - 系统可用性：≥99.5% - 日均筛查人次：目标第1年50人次（单机构10人次），第2年500人次

7.2 版本里程碑规划

版本	时间	核心目标	关键功能
V1.0 MVP	2026 Q3	验证核心筛查流程	AD8量表筛查、语音交互、结果报告、B端数据看板
V1.5 试点	2026 Q4	5家机构试点运营	家属代测、微信注册、认知训练干预
V2.0 规模化	2027 Q2	50家付费机构	AI智能分析、就医推荐、在线问诊对接
V3.0 合规	2027 Q4	NMPA医疗器械申报	临床验证数据积累、合规体系建设

8. 风险评估与应对

风险类型	风险描述	影响等级	应对策略
医疗合规风险	用户将自测结果作为诊断依据，延误就医	高	1. 全流程显著位置展示医学免责声明2. 明确标注“不能替代专业诊断” 3. 高风险结果强制建议就医

数据隐私风险	健康数据泄露，违反个保法	高	1. 端到端加密传输和存储2. 数据匿名化处理3. 通过等保三级认证
医疗器械准入	数字疗法认证周期长、成本高	中	1. 分阶段申请，先做低风险类别2. 与有经验的CRO公司合作3. 提前布局临床数据积累
市场教育成本高	机构和用户认知不足	中	1. 标杆客户示范效应2. 免费试用降低准入门槛3. KOL学术推广
竞品快速跟进	大厂进入，竞争加剧	中	1. 深耕垂直领域，建立专业壁垒2. 积累临床数据，形成护城河3. 生态合作，构建开放平台
AI模型准确性	AI分析结果偏差，误导用户	中	1. 建立专家审核机制2. 持续迭代优化算法3. 设置置信度阈值，低置信度人工复核
